¿Cuáles fueron los efectos que tuvo la campaña de prevención, control y vigilancia de la transmisión de las enfermedades producidas por el mosquito Aedes Aegypti en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Comuna 11, en los años 2023-2024 y 2024-2025? Haciendo hincapié en sus ejes comunicacionales

Autores: Bosio Camila Belén, Fuentes Diego, Mahia Marina Marisa

Tutores: Margarita Cejas y Leandro Alassia

Código de grupo 2025-MS-AR-23

Análisis de génesis e impacto de una política pública

18/12/2025

Entrega N° 5

Programa de Especialistas Profesionales
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Quisiéramos hacer especial mención a Facundo Verdera, integrante de la Coordinación de Enfermedades de Transmisión del Mosquito, quién con buena predisposición y paciencia nos ha facilitado los datos que han hecho posible este trabajo.
A él, gracias.

Índice

Resumen…… 3

Introducción……. 4

Antecedentes y marco teórico……6

Antecedentes……..6

Marco teórico…….9

Tipo de investigación, metodología, objetivos e hipótesis……...12

Recolección de datos……....13

Análisis de los datos recolectados……....14

Conclusiones……....22

Propuestas a futuro……..… 25

Bibliografía……. 26

Anexo……. 28

Resumen

El presente trabajo analiza el impacto del plan comunicacional del Plan de Prevención, Control y Vigilancia del Dengue implementado por el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en la Comuna 11, durante los períodos 2023–2024 y 2024–2025. La investigación surge en un contexto de crecimiento sostenido de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, lo que demanda estrategias de comunicación pública más eficaces para promover conductas de autocuidado y fortalecer la prevención comunitaria.

El objetivo principal fue evaluar la efectividad y el alcance de la campaña de comunicación en la Comuna 11, identificando su incidencia en 3 ejes principales: las acciones territoriales, el plan de comunicación y el seguimiento de los casos confirmados.

Los resultados muestran diferencias contundentes entre las campañas 2023–2024 y 2024–2025 en los tres ejes analizados. Si bien no puede establecerse causalidad directa entre comunicación y reducción de casos, la evidencia sugiere que una campaña sostenida, visible y con presencia territorial incrementa la concientización social y mejora la capacidad de respuesta frente a los brotes.

A futuro, se recomienda ampliar los estudios de impacto comunicacional que permitan cuantificar con mayor precisión la incidencia de las campañas en la reducción de casos y optimizar la efectividad de las políticas públicas de salud.

Introducción

Para este trabajo elegimos el **tipo** de investigación de **análisis de génesis e impacto de una política pública** porque consideramos que es interesante analizar cuáles son los contextos sociales que llevan a impulsar la implementación de una política pública en la ciudadanía. Además porque creemos que la evaluación del impacto de una política pública nos permite tener un conocimiento de sus resultados y sólo así podemos hacer modificaciones que los optimicen para brindar un servicio de mejor calidad a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Consideramos como **problema** la propagación del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor de las enfermedades de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, en los últimos años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estas enfermedades virales representan un desafío importante para la salud pública local, ya que pueden generar epidemias con consecuencias graves para la población, especialmente en zonas con alta densidad urbana y condiciones propicias para la proliferación del mosquito. Por ello, la Ciudad ha desarrollado un plan estratégico para prevenir, controlar y vigilar la transmisión de las enfermedades provocadas por este mosquito, con el objetivo de disminuir los brotes, minimizar el impacto sanitario y reducir la tasa de mortalidad.

El plan estratégico de la Ciudad tiene como principal objetivo reducir la propagación de enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, mediante un conjunto de medidas que involucran tanto la prevención como el control de los criaderos del mosquito. Estas actividades se centran en el control y eliminación de criaderos de mosquitos, la distribución de información sobre métodos de prevención de picaduras y la promoción del uso de dispositivos de aislamiento vectorial como repelentes, espirales y mosquiteros.

En este contexto, también se han implementado campañas de vacunación contra el dengue, que son cruciales para reducir la transmisión del virus y minimizar la gravedad de los casos. Sin embargo, la prevención no solo se limita a la eliminación de criaderos o a la vacunación. Un elemento clave para el éxito de estas campañas es la comunicación efectiva, tanto en términos de la información transmitida a la población como en la gestión de datos epidemiológicos. Es fundamental que los ciudadanos reciban información clara sobre los

riesgos, las medidas preventivas y la importancia de colaborar activamente en la lucha contra el mosquito. Asimismo, *la estrategia comunicacional debe ser integral, abarcando desde la divulgación de mensajes educativos hasta el fortalecimiento del circuito de información de datos relacionados con los casos y las áreas afectadas, para poder tomar decisiones informadas en tiempo real.*

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede presentar epidemias y es por esto que ha desarrollado un plan estratégico para prevenir, controlar y vigilar la transmisión de las enfermedades producidas por este mosquito para disminuir los brotes, minimizar su impacto y reducir su tasa de mortalidad[1].
Para llevar a cabo esta política pública el plan menciona la necesidad de participación de actores estratégicos como: instituciones públicas (hospitales, escuelas, edificios públicos) así como acciones comunitarias coordinadas, en su mayoría, en las sedes comunales[2]

Por lo tanto, la presente investigación se propone analizar los **efectos de la campaña de prevención, control y vigilancia** de la transmisión de enfermedades provocadas por el *Aedes aegypti* en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los años 2023-2024 y 2024-2025, con un enfoque particular en el impacto del **plan comunicacional** utilizado en la campaña. Asimismo, se busca identificar los **ejes comunicacionales** que estructuraron la campaña, para evaluar su efectividad y contribuir a la optimización de futuras intervenciones en la materia.

Es por esto que lo mencionado anteriormente nos lleva a **preguntarnos**, ¿Cuáles fueron los efectos que tuvo la campaña de prevención, control y vigilancia de la transmisión de las enfermedades producidas por el mosquito *Aedes aegypti* en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los años 2023-2024 y 2024-2025?
¿Qué repercusiones tuvo el plan comunicacional en la campaña de prevención de la transmisión de estas enfermedades?

---

[1] Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ([s.f.]). *Plan preventivo de enfermedades transmitidas por mosquitos*. BA. https://buenosaires.gob.ar/salud/plan-dengue-y-otras-enfermedades-transmitidas-por-mosquitos-aedes- aegypti/plan-preventivo-de

[2] Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ([s.f.]). *Plan estratégico-operacional integrado Prevención, control y vigilancia de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti*. buenosaires.gob.ar. https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2023-02/Plan%20estrat%C3%A9gico-operacional%20integrado.pdf

Antecedentes y marco teórico

Antecedentes

La propagación del mosquito *Aedes aegypti* representa un fenómeno de creciente relevancia en la salud pública global. Originario de regiones tropicales y subtropicales, este vector ha ampliado su presencia territorial debido a factores como el cambio climático, el crecimiento urbano y la globalización. En América Latina, el mosquito ha sido responsable de brotes cíclicos de enfermedades como fiebre amarilla, dengue, zika y chikungunya.

A nivel regional, diversos países han implementado planes de acción integrales que combinan la vigilancia epidemiológica, el control focal de criaderos, campañas de comunicación comunitaria y, recientemente, estrategias de vacunación. Por ejemplo, Brasil ha sido pionero en la liberación de mosquitos modificados genéticamente, mientras que Colombia ha fortalecido su sistema de alerta temprana con base en datos georreferenciados. La prevención depende del control del vector, ya sea con uso de productos químicos como de medios mecánicos, para lograr esto la participación de las comunidades es fundamental para su éxito.

En el año 2013, según un artículo publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Argentina no era un territorio endémico de dengue. Si bien ya se detectaba la presencia del vector en el país esto fue consecuencia de los "viajeros infectados provenientes de países con circulación viral o de zonas del país en las que se (...) [estaba] desarrollando un brote"[3]

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en 2023, la ciudad enfrentó uno de los brotes más significativos de los últimos años, lo que motivó la intensificación de las campañas de prevención y control por parte del Gobierno porteño. En CABA, el Plan Estratégico contra el *Aedes aegypti* ha incluido lineamientos para la vigilancia, prevención y control, desde controles operativos en territorio hasta campañas de comunicación masiva orientadas a modificar comportamientos ciudadanos, componentes esenciales para una acción efectiva.

[3] Organización Panamericana de la Salud (2013, Octubre 7). Funcionarios y expertos de 23 países analizan en Argentina las estrategias contra el dengue. Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/es/noticias/7-10-2013-funcionarios-expertos-23-paises-analizan-argentina-estrategias-contra-dengue

Informes del Ministerio de Salud de la Ciudad y boletines epidemiológicos publicados muestran cómo los picos de casos estuvieron asociados a momentos del año con condiciones climáticas determinadas. El Boletín Epidemiológico Semanal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud tiene a cargo informar sobre las enfermedades que afectan a la jurisdicción. En su entrega Nª 371 del 29 de septiembre de 2023 en la sección de zoonóticas y por vectores, exponen que, hasta la semana 37 del año 2022, de un total de 152 casos reportados de dengue, solo 17 correspondían a casos Confirmados (C), Probables (P) o Sospechosos (S). En comparación, durante el mismo período pero del año 2023 se presentaron de un total de 21.282 casos reportados, 20.111 casos C, P o S. Esto significa que durante ese período hubo un aumento muy significativo de casos.

Por otro lado, si bien en ninguno de los dos períodos, de 2022 y 2023, se reportaron casos de zika, ni se confirmaron casos de fiebre amarilla, sí los hubo de fiebre chikungunya. Hasta la 37ava semana del año 2022 no hubo casos reportados, sin embargo un año más tarde se reportaron 233 casos de los cuales 152 resultaron C, representando un 65% de los mismos[4].

Estas enfermedades provocan los siguientes síntomas; en el caso del dengue "causa fiebre con dolor de cabeza, erupción cutánea y dolores musculares debilitantes"[5], en el de chikungunya "provoca fiebre alta, intensos dolores en las articulaciones, sarpullido, dolor de cabeza y muscular"[6] mientras que en el de zika "es una enfermedad viral que consiste en fiebre leve, sarpullido, dolor de cabeza, malestar general y conjuntivitis no purulenta"[7]. En las tres virosis mencionadas se reporta una evolución favorable de la mayoría de los casos, existiendo una minoría que requiere hospitalización con posible riesgo de muerte.

---

[4] Boletín Epidemiológico Semanal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2023). N° 371 Boletín epidemiológico semanal Información hasta SE 37 Año VIII | 29 de septiembre 2023 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Boletín epidemiológico semanal, 9. https://buenosaires.gob.ar/salud/boletines-epidemiologicos-semanales-2023.

[5] Organización Panamericana de la Salud (2015, Noviembre 6). Países de las Américas se preparan frente al dengue, chikungunya y zika. Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/es/noticias/6-11-2015-paises-americas-se-preparan-frente-al-dengue-chikungunya-zika-0

[6] Organización Panamericana de la Salud (2015, Noviembre 6). Países de las Américas se preparan frente al dengue, chikungunya y zika. Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/es/noticias/6-11-2015-paises-americas-se-preparan-frente-al-dengue-chikungunya-zika-0

[7] Organización Panamericana de la Salud (2015, Noviembre 6). Países de las Américas se preparan frente al dengue, chikungunya y zika. Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/es/noticias/6-11-2015-paises-americas-se-preparan-frente-al-dengue-chikungunya-zika-0

En el año 2024 la OPS publica una *Guía de mensajes clave destinados a individuos, familias y comunidad sobre las acciones preventivas y el control para combatir al mosquito Aedes aegypti transmisor del dengue, chikungunya, Zika y otras arbovirosis en las Américas* con el objetivo de concientizar sobre las características principales del mosquito *Aedes Aegypti* y sobre las medidas para su control haciendo hincapié en aquellas dirigidas a la población[8].

Es en este marco que, en el mismo año, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanza el nuevo ***Plan estratégico-operacional integrado: Prevención, control y vigilancia de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti*** con los objetivos de minimizar la morbimortalidad y disminuir el riesgo de propagación de brotes.

Los principales ejes en los que se basa este plan comprenden: la participación comunitaria, la comunicación y educación para la salud, el control epidemiológico de casos, el monitoreo de las acciones interministeriales, el saneamiento ambiental y la asistencia a los enfermos[9]. En cada uno de estos ejes se establecen actividades concretas a llevar a cabo.

En el presente trabajo analizaremos los efectos que tuvieron las acciones comprendidas en los ejes de participación comunitaria, comunicación y educación para la salud y asistencia a los enfermos.

En primer lugar, nos detendremos en el eje de ***participación comunitaria*** que tiene por objetivo concientizar sobre el impacto de las acciones individuales, promover las acciones comunitarias y crear alianzas entre el Estado, el tercer sector y los medios de comunicación para abordar la prevención como una tarea colectiva y continua. En este sentido, el plan comprende las siguientes acciones comunitarias para trabajar las diferentes etapas epidemiológicas. Por un lado, las intervenciones comunitarias con recorridas en los barrios para promover entornos libres del vector a través del accionar vecinal. Este eje contempla además la realización de recorridas en determinadas instituciones y organizaciones y también en aquellos lugares reportados mediante la plataforma de Gestión Colaborativa como

[8] Organización Panamericana de la Salud (2024). Guía de mensajes clave destinados a individuos, familias y comunidad sobre las acciones preventivas y el control para combatir al mosquito *Aedes aegypti* transmisor del dengue, chikungunya, Zika y otras arbovirosis en las Américas. Organización Panamericana de la Salud . https://iris.paho.org/handle/10665.2/59569

[9] Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2024). Plan estratégico-operacional integrado Prevención, control y vigilancia de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. gcba.buenosaires.gob.ar.

sospechosos de la presencia de criaderos. En un segundo nivel, este plan operacional contempla como acción la capacitación de promotores de salud y otros actores de áreas de gobierno en lo que refiere al proceso de atención, autocuidado, cuidado y enfermedad relacionados a las virosis. Sobre los mismos temas se hace referencia también a capacitaciones a la ciudadanía. Y como última acción dentro de este objetivo se encuentra la comunicación masiva sobre cómo prevenir las enfermedades a través de distintos canales.

En segundo lugar, el plan estratégico operacional contempla el ***eje de comunicación y educación para la salud*** que se basa en una estrategia de comunicación integral que atraviesa todas las áreas del plan, con el objetivo de promover la participación activa y la movilización de la comunidad. Se construyen mensajes que articulan conocimientos técnicos, sociales, comunicacionales y políticos, adaptados a los distintos contextos epidemiológicos. Además, se mantiene una comunicación constante con los medios y actores clave, informando sobre la situación del dengue y las acciones implementadas. También se fortalecen los canales de comunicación interna entre organismos para garantizar una difusión eficaz y coordinada de las medidas adoptadas.

En tercer y último lugar nos detendremos en el eje de ***asistencia a los enfermos.*** El trabajo conjunto del equipo de salud se debe iniciar desde el triage realizado en el servicio de guardia de cada institución de salud por el personal de enfermería y médico, e incluir las instancias posteriores de atención médica en guardia: estudios complementarios e interpretación de los mismos para considerar su tratamiento. En el caso de pacientes que no requieran internación, el personal debe estar capacitado para brindar información precisa para el seguimiento de la enfermedad, es decir controles y laboratorios cada 24 o 48 horas e identificación de signos de alarma. Por otro lado, también debe saber explicar qué medicamentos puede o no utilizar y ante qué síntomas.

Marco teórico

Para abordar esta investigación, se toman como referencia conceptual diversos marcos analíticos provenientes de la salud pública, la comunicación estratégica y el análisis de políticas públicas.

A) Políticas Públicas: Conceptualización

Las políticas públicas pueden entenderse como el conjunto de decisiones y acciones deliberadas del Estado, orientadas a transformar determinadas condiciones sociales consideradas problemáticas, en un contexto de disputas entre intereses diversos (Vilas, 1994). Este enfoque resalta que las políticas no son neutras, sino que reflejan relaciones de poder y modelos de sociedad. *En el campo de la salud, estas decisiones adquieren especial relevancia al estar vinculadas directamente con los derechos sociales y la equidad*. En esta línea, Ramón Carrillo, primer Ministro de Salud Pública de la Nación Argentina, definió las políticas sanitarias como un "conjunto de acciones organizadas y sistemáticas del Estado para prevenir y controlar enfermedades, promover la salud y garantizar el acceso equitativo a servicios de salud" (Carrillo, 201 tb 8).

B) Políticas Públicas de Salud y Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores: Aplicación al Caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2023/2025)

En el ámbito de la salud, las políticas públicas juegan un rol clave en la planificación, prevención y respuesta frente a amenazas sanitarias. La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) destaca que las enfermedades transmitidas por vectores requieren un enfoque de gestión integrada, con participación activa de la comunidad, acciones multisectoriales, y vigilancia epidemiológica constante.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Ministerio de Salud ha desarrollado una estrategia integral para el control y prevención del dengue que incluye visitas domiciliarias, campañas de concientización en medios y redes sociales, monitoreo entomológico y participación comunitaria. Estas acciones forman parte de una política pública que articula salud, ambiente y participación ciudadana, en línea con enfoques propios del pensamiento sanitario latinoamericano.

Este tipo de intervenciones se enmarcan en el Modelo de Atención Primaria de Salud (APS), cuya adopción en América Latina fue impulsada por la Declaración de Alma-Ata (1978), y que enfatiza la importancia de la participación comunitaria, la prevención y la equidad en el acceso a servicios de salud (OPS, 2007). Además, se refleja un enfoque ecosistémico de la salud pública, que considera las condiciones sociales, ambientales y económicas como determinantes fundamentales de la salud colectiva, un concepto desarrollado por autores como Paulo Buss y Sergio Pacheco (Buss & Pacheco, 2015).

La gobernanza en salud, entendida como la articulación entre el Estado, la sociedad civil y otros actores para el diseño e implementación de políticas, es otro modelo clave que sustenta la estrategia del gobierno porteño (Vargas & Pérez, 2013). La participación barrial y las visitas domiciliarias también pueden enmarcarse en el modelo de intervención comunitaria, que en América Latina ha sido desarrollado y validado por diversos autores como Julio Frenk, exministro de Salud de México (Frenk, 2010).

Finalmente, la vigilancia epidemiológica y el monitoreo entomológico que sostienen la campaña están basados en un enfoque de salud pública basada en evidencias, fundamental para garantizar la efectividad y la sostenibilidad de las intervenciones (Béliveau & Durán, 2017).

Esta política pública integral se alinea con la Ley Nacional N.º 26.529 de Derechos del Paciente y con el enfoque "Salud en todas las políticas" promovido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2016).

C) Comunicacion y educacion para la salud

La comunicación y la educación para la salud son pilares fundamentales en las estrategias de prevención y control de enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, como el dengue, el zika y la fiebre chikungunya. Ambos ejes se integran de manera sinérgica en los planes sanitarios, ya que permiten no solo transmitir información, sino también fomentar la participación activa de la población, el cambio de conductas y la apropiación colectiva de prácticas saludables.

Desde una perspectiva moderna, la comunicación para la salud no se reduce a la simple difusión de mensajes, sino que se concibe como un proceso dialógico, intercultural y participativo. Los contenidos deben construirse de forma contextualizada, en diálogo con las comunidades y actores clave, y alinearse con las estrategias sanitarias generales. En este marco, la comunicación busca involucrar a la ciudadanía, generando conciencia colectiva, corresponsabilidad y apropiación de las acciones preventivas.

Por su parte, la educación para la salud se entiende como un proceso sostenido que facilita la adquisición de conocimientos, el cambio de actitudes y la incorporación de conductas beneficiosas para la salud individual y colectiva. En el caso del dengue, esto se traduce en acciones concretas como la identificación y eliminación de criaderos del mosquito, el

reconocimiento de síntomas y la consulta temprana. Las campañas educativas implementadas en escuelas, barrios y medios de comunicación son esenciales para lograr una participación informada y sostenida.

Finalmente, para que estas estrategias sean efectivas, es necesaria una articulación interinstitucional sólida y mecanismos de comunicación interna eficientes entre las distintas áreas del gobierno y los equipos técnicos. Esto permite unificar criterios, evitar mensajes contradictorios y optimizar los recursos disponibles.

Durante el período 2023–2025, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desplegó una serie de campañas de prevención y control del dengue con fuerte presencia territorial y en medios de comunicación. **Estas campañas combinaron mensajes gráficos, audiovisuales, actividades comunitarias y acciones en redes sociales, estructuradas en torno a una estrategia comunicacional integral. Evaluar su impacto implica no solo observar los indicadores epidemiológicos, sino también analizar el grado de apropiación comunitaria,** la claridad de los mensajes, la participación lograda y la sostenibilidad de las conductas preventivas promovidas.

Tipo de investigación, metodología, objetivos e hipótesis

Para realizar esta investigación decidimos analizar la génesis y el impacto de una política pública utilizando una **metodología** con enfoque mixto cuantitativo cuyo **objetivo genera**l es evaluar el impacto de la campaña de prevención del dengue en la Comuna 11 en los años 2023-2024 y 2024-2025. Tomando por **objetivos específicos**: describir las acciones de la campaña en los 3 ejes mencionados en ambos períodos, comparar los casos registrados de dengue y barajando como **hipótesis** que una campaña más sostenida y visible se asocia a una mayor concientización de la población y por lo tanto a una contención más efectiva de los brotes de dengue.

Recolección de datos

El proceso de recolección de datos se desarrolló en función del enfoque metodológico adoptado, orientado a examinar los efectos comunicacionales de la campaña de prevención, control y vigilancia de las enfermedades transmitidas por el mosquito *Aedes aegypti* en la Comuna 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los períodos octubre de 2023 a mayo de 2024 y octubre de 2024 a mayo de 2025.

Los datos que analizaremos abarcan el período de octubre del año 2023 a mayo del 2024 y de octubre del año 2024 a mayo del 2025 y versarán sobre los 3 ejes elegidos: *participación comunitaria, comunicación y educación para la salud y asistencia a los enfermos*. El objetivo será poder ver los efectos de la cantidad de acciones de comunicación realizadas en los resultados de las campañas.

En el primer **eje de participación comunitaria** se tomarán como indicadores las siguientes acciones territoriales realizadas: talleres, actividades de concientización, registro de oviposturas, gestiones de las denuncias realizadas mediante la plataforma de gestión colaborativa y los estudios de foco.

El segundo eje, **comunicación y educación para la salud**, comprenderá las 2 etapas del plan de comunicación que abarcan el período investigado, una correspondiente a la etapa de prevención (octubre a diciembre) y la otra a la etapa de casos (enero a mayo).

En relación con el eje de comunicación y educación para la salud, se relevaron las estrategias institucionales de difusión implementadas por el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MSGCABA).
Las acciones comunicacionales de la campaña se difundieron de manera sistemática a través de los canales oficiales del organismo, a saber:

- Las redes sociales institucionales del Ministerio de Salud del Gobierno de La Ciudad (Facebook, Instagram y Twitter):

  Facebook: Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (BASalud) Facebook+1

  Instagram: @saludba Instagram

Twitter / X: @BASalud x.com+1

- Las redes sociales del Ministro de Salud, en las que se encuentra enlazado el canal denominado *"Hablemos de dengue"*.
- El sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad (buenosaires.gob.ar), particularmente el espacio correspondiente al *Plan de Dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes aegypti*.
- La sección de Noticias del portal oficial (Noticias ETM), donde se publicaron comunicados, actualizaciones y materiales informativos sobre las distintas etapas de la campaña.

Asimismo, los canales de comunicación han sido los utilizados de manera continua en las campañas de años anteriores, garantizando así coherencia comunicacional y continuidad institucional en la difusión de los mensajes preventivos.

Y por último, el tercer eje de **asistencia a los enfermos** será analizado en función de los datos que proveyó el sistema de salud para el posterior seguimiento y tratamiento en los estudios de foco.

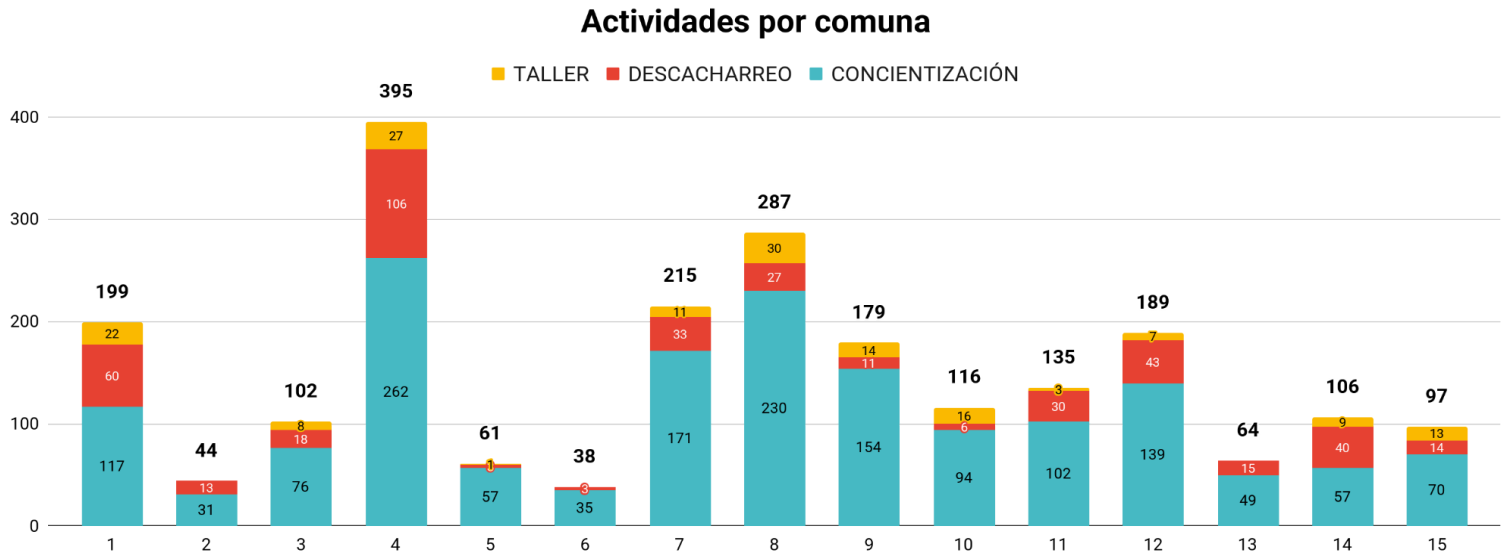
Para obtener estos datos se relevaron **fuentes** de elaboración **interna** de la Coordinación a cargo de las Enfermedades Transmitidas por el Mosquito (ETM) y también fuentes **oficiales** que incluyen: datasets públicos (boletines epidemiológicos a cargo de la Gerencia Operativa de Epidemiología) y otros documentos como cronograma de campaña del Plan de Dengue y comunicados de prensa, redes sociales institucionales, etc.

Análisis de los datos recolectados

Dentro del primer eje, ***Participación Comunitaria*** relevamos las siguiente acciones:

Talleres

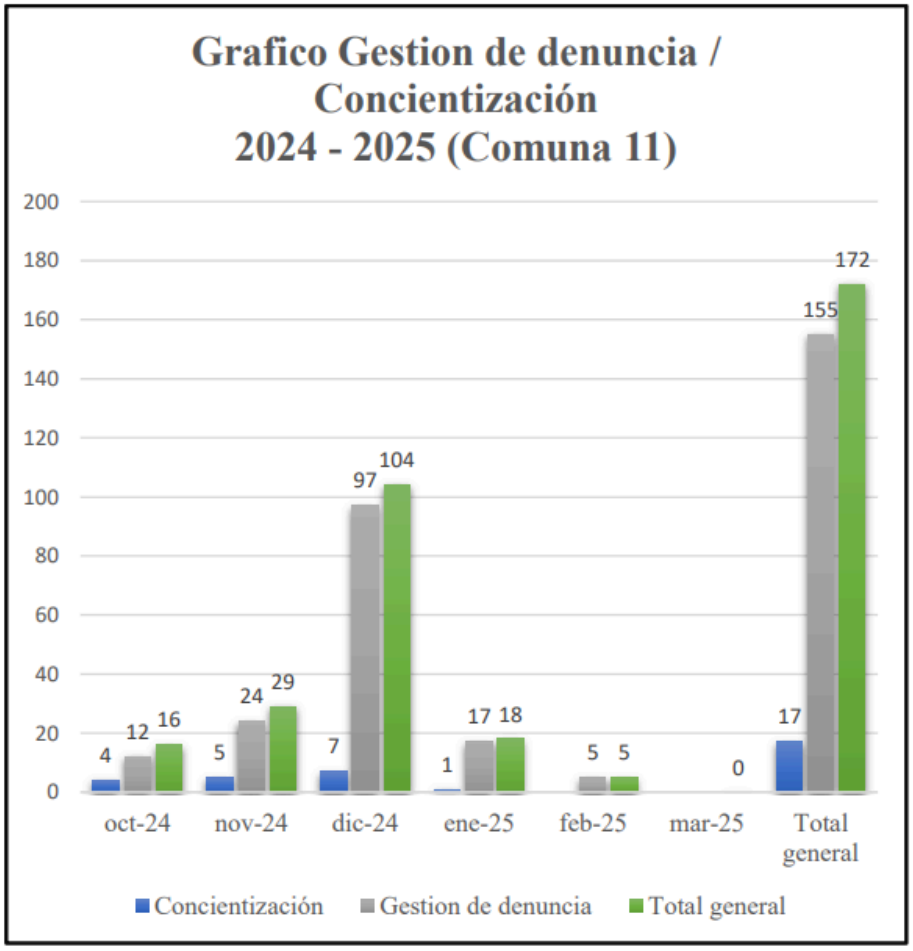
El siguiente gráfico menciona los talleres realizados en el período junio 2024 a febrero 2025 en cada comuna de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede observar que en el período mencionado se hicieron 5 talleres en la Comuna 11.



Fuente: Elaboración a cargo de la Coordinación de las Enfermedades Transmitidas por el Mosquito (ETM). 2025.

<u>Concientizaciones y Gestión de denuncia</u>

Con los datos relevados a partir de los datasets proporcionados por la Coordinación ETM se elaboró el siguiente gráfico que da cuenta de las actividades de Concientización realizadas entre octubre del año 2024 y marzo del año 2025. Se registraron un total de 17 para la Comuna 11, teniendo lugar la mayoría, 7, en el mes de diciembre. Por otro lado las acciones que se realizaron como motivo de respuesta a las denuncias de los vecinos cargadas por la plataforma de Gestión Colaborativa también tuvieron su pico máximo en el mes de diciembre llegando a las 97 intervenciones.

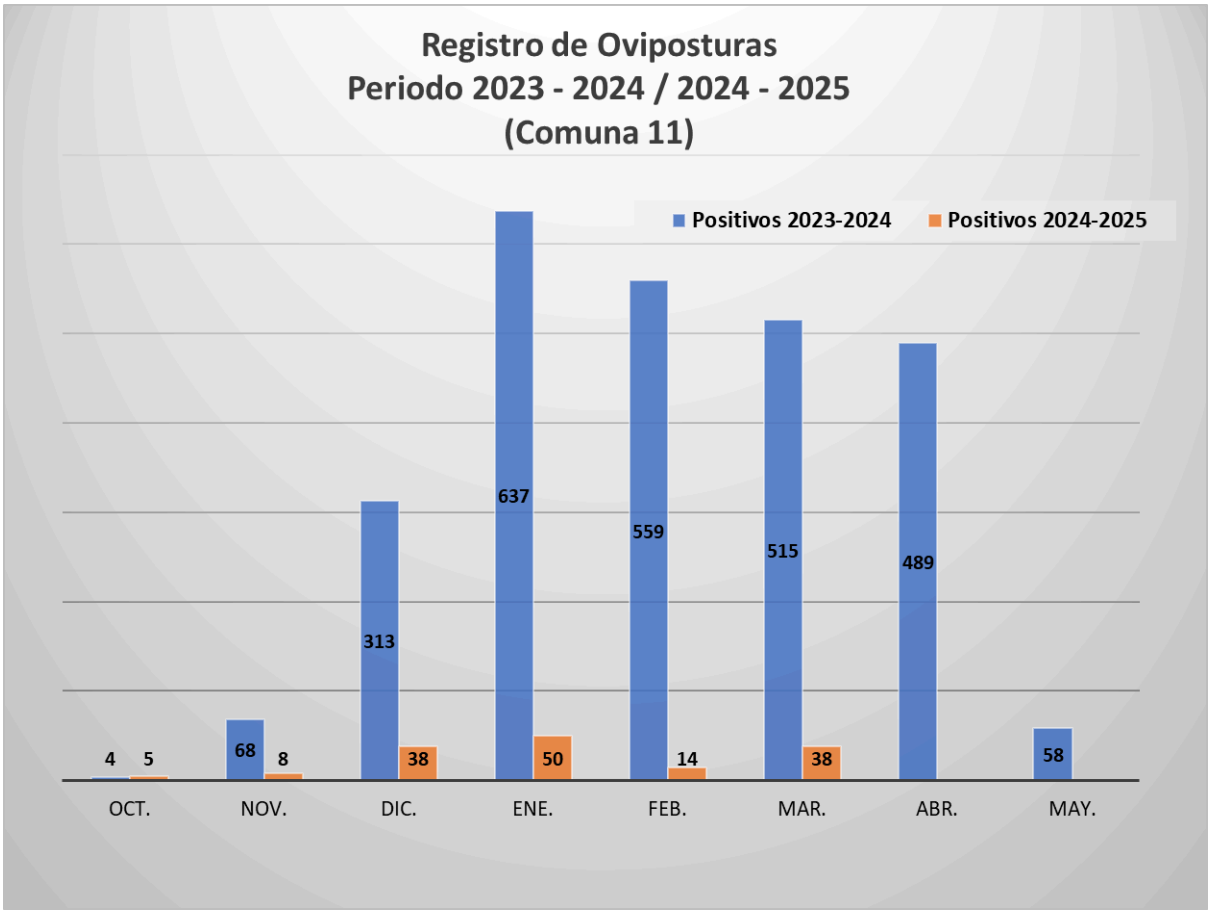


Fuente: Elaboración propia.2025.

Oviposturas

Con la fuente anteriormente mencionada se realizó un gráfico que da cuenta del registro de oviposturas positivas en los períodos 2023-2024 y 2024-2025 en la Comuna 11. Podemos ver que en el primer período analizado hubo un pico máximo de oviposturas positivas de 637 en el mes de enero del año 2024, mientras que el mismo mes del año siguiente, 2025, también presentó el pico máximo pero tan solo con 50 oviposturas positivas. De esta manera se puede ver que se redujeron en casi un 92% su presencia. A diferencia del período anterior, durante

el 2024-2025 las oviposturas positivas reportadas eran seguidas por una concientización territorial del espacio circundante.



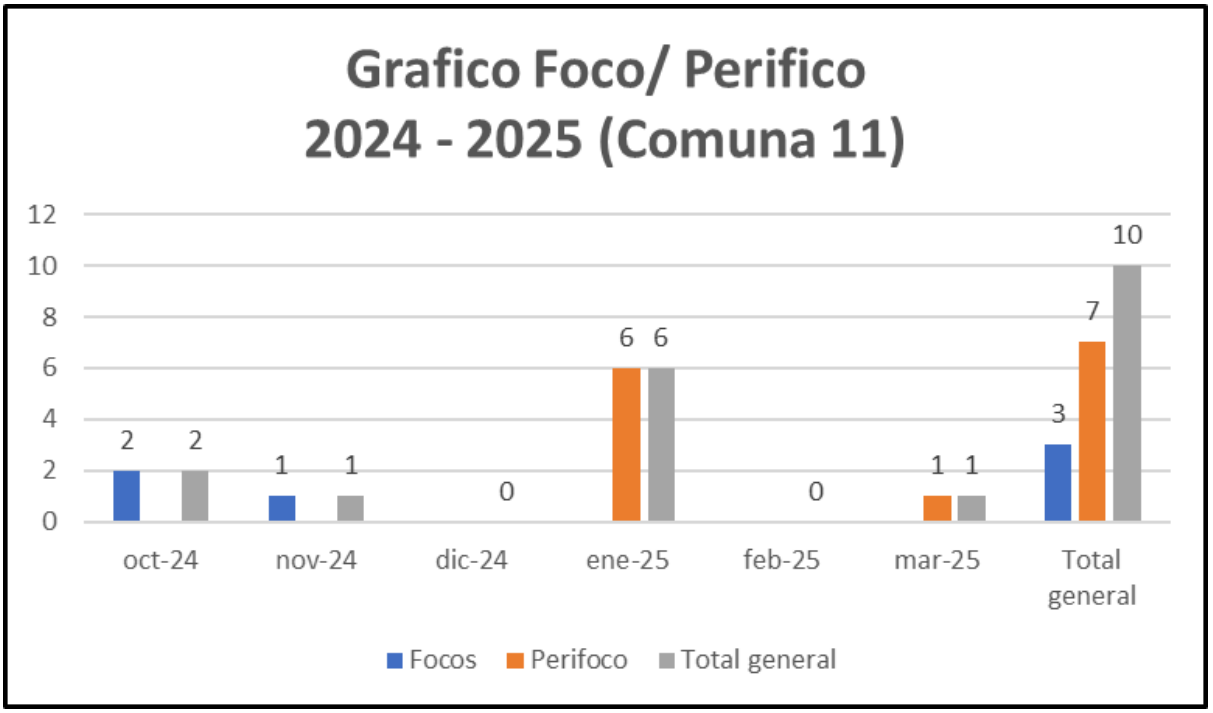
Fuente: Elaboración propia.2025.

Estudio de foco y perifoco

Por último, y en línea con las mismas fuentes utilizadas para realizar los otros gráficos, se realizó uno que da cuenta de los estudios de foco y perifoco realizados en la Comuna 11.

Durante el 2023-2024 se realizaron estudios de foco solo donde había cierto número de clusters, es decir de casos confirmados de dengue; y constaban de llamados telefónicos para realizar el seguimiento de los infectados. Sin embargo en el segundo período analizado en esta investigación, 2024-2025, los estudios de foco constaban de un seguimiento presencial de la persona confirmada de dengue, información que era relevada por el sistema de salud. Al

mismo tiempo se sumaron los perifocos que se basaron en eliminar criaderos y ofrecer servicios de fumigación en el domicilio y 150m^2 a la redonda. La mayor cantidad de intervenciones realizadas fueron los perifocos durante el mes de diciembre.



Fuente: Elaboración propia. 2025.

Dentro del segundo eje, ***Comunicación y educación para la salud***, relevamos las 2 etapas del plan de comunicación: del análisis del material recolectado se desprende que la estrategia comunicacional del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se estructuró sobre una base institucional sólida y multicanal, con especial énfasis en la difusión digital y la educación sanitaria preventiva.

Durante la etapa de prevención (octubre a diciembre), los mensajes difundidos priorizaron la concientización sobre medidas domiciliarias de eliminación de criaderos, la limpieza de patios y recipientes, y la responsabilidad ciudadana en la reducción del vector. Estos contenidos, de carácter educativo, se presentaron con un lenguaje claro y accesible, acompañados de recursos visuales que reforzaron la comprensión de los mensajes.

En la etapa de casos (enero a mayo), la comunicación institucional adoptó un enfoque más orientado a la detección temprana y el acompañamiento sanitario, difundiendo información

sobre síntomas de alarma, vías de atención y medidas de cuidado personal y familiar.
Este cambio en la orientación de los mensajes evidencia la existencia de un plan comunicacional estructurado en dos fases complementarias, coherente con la dinámica estacional del dengue en la Ciudad.

El análisis comparativo entre los dos períodos estudiados (2023–2024 y 2024–2025) revela una consistencia discursiva e institucional en la implementación de las campañas, caracterizada por la continuidad en el uso de los canales oficiales y la reiteración de mensajes clave, lo cual contribuyó a consolidar una identidad comunicacional reconocible.
Sin embargo, **se identifican limitaciones en la disponibilidad de datos cuantitativos sobre el alcance efectivo de las publicaciones y la interacción ciudadana en redes sociales**, lo cual dificulta una medición precisa del impacto comunicacional en términos de cambio de comportamiento o nivel de recordación.

Análisis del contenido sobre dengue en las redes sociales institucionales del Ministerio de Salud (GCBA)

Prevención doméstica y comunitaria — mensajes prácticos y repetidos que explican medidas para reducir criaderos: eliminar recipientes con agua estancada, mantener tapados los tanques, uso de repelente, limpieza de patios y balcones. Suelen difundirse en formato de infografías y posteos permanentes.

Síntomas y orientación clínica básica — publicaciones con lista de signos (fiebre, dolor muscular/articular, manchas en la piel) y recomendaciones sobre cuándo acudir a un centro de salud. Esto aparece en posts y tuits como material informativo.

Campañas y operativos territoriales — comunicación sobre operativos de búsqueda activa, visitas domiciliarias o control larvario, y coordinación con comunas; a veces se acompañan de fotos o reels mostrando equipos de salud en terreno.

Vacunación y recursos oficiales — difusión de información sobre la campaña de vacunación cuando corresponde (coberturas, grupos priorizados) y enlaces o remisiones a páginas oficiales para más detalle. En algunos posts se remite a servicios como el Boti (147) para

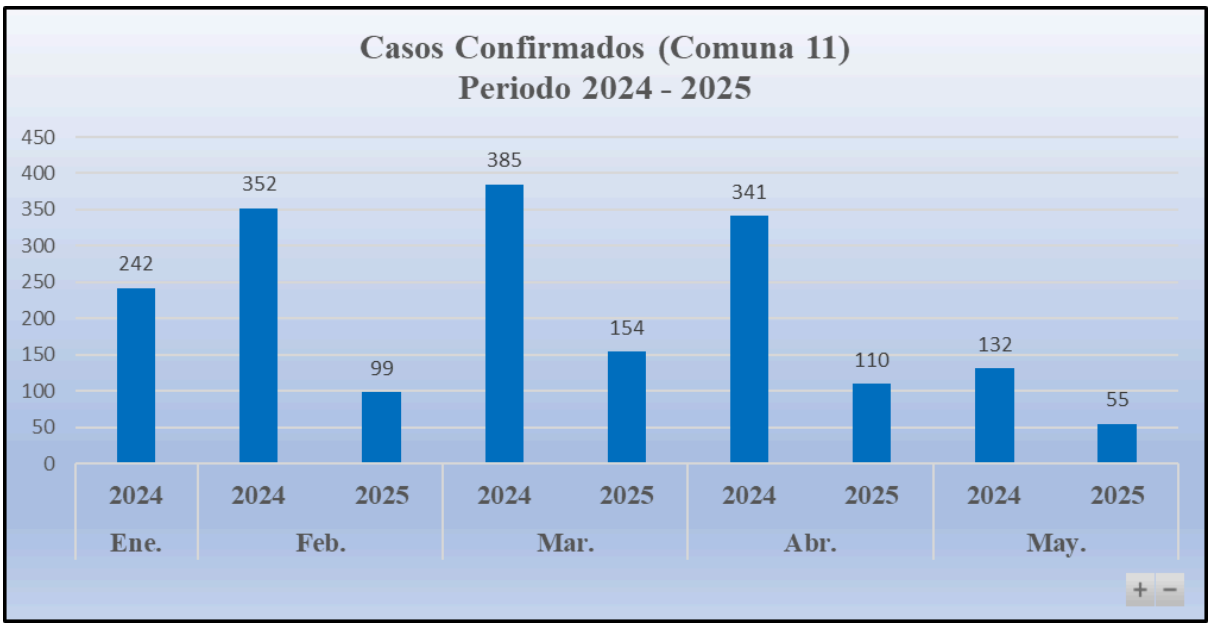
consultas o denuncias.

Información de vigilancia / datos epidemiológicos — ocasionalmente difunden boletines o resúmenes sobre la situación epidemiológica (casos, situación por comuna), aunque los datos más detallados y los boletines completos suelen estar en el sitio institucional (web/canales oficiales). Para contexto epidemiológico nacional/regional recurren a comunicados y a reportes de temporada.

Dentro del tercer eje, ***Asistencia a los enfermos***, relevamos los datos que proveyó el sistema de salud.

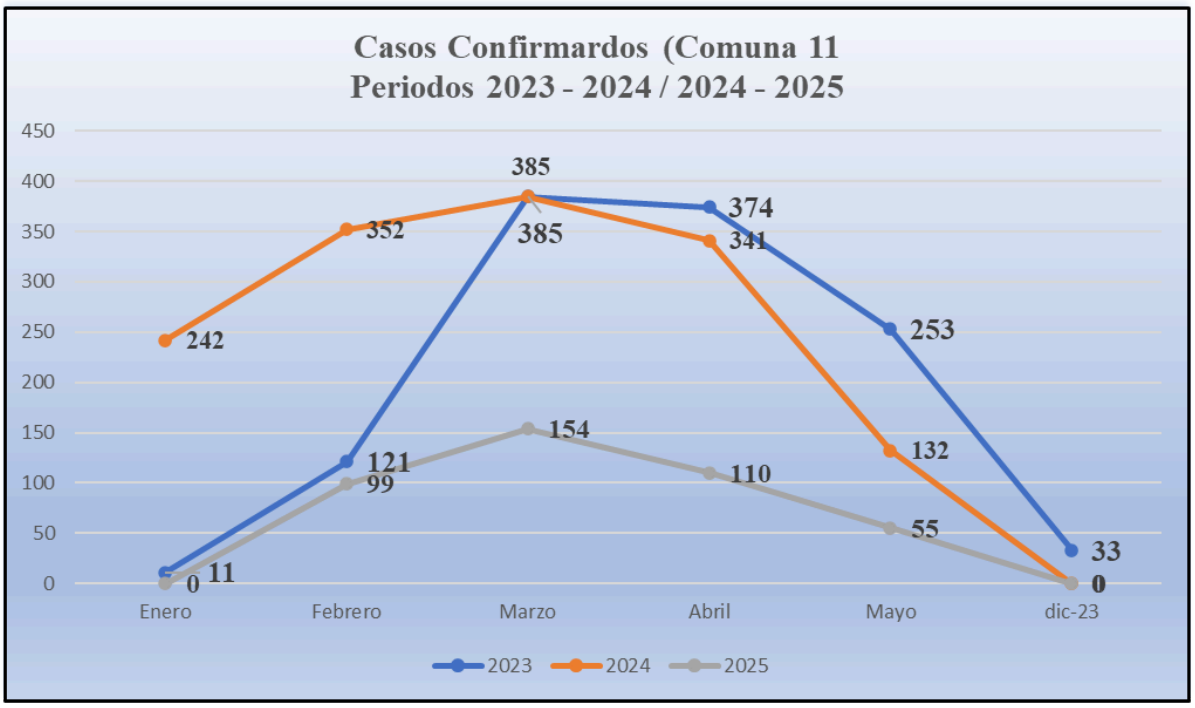
Fuente: Elaboración propia. 2025.

Como podemos observar en el mes de enero 2024 hubo, en comparación con el 2023, un notable aumento de casos confirmados de dengue. Sin embargo en el mes de marzo de ambos años notamos que hubo la misma cantidad de casos.
Y para finalizar durante los meses de abril /mayo empezaron a descender notablemente los casos respecto del 2023.



Fuente: Elaboración propia. 2025.

En este gráfico se observa que en el mes de enero 2024 hubo 242 casos confirmados de dengue y mientras que en el mismo mes del 2024, no hubo. Luego desde el mes de marzo hasta mayo del 2025 hay un descenso constante de casos respecto al 2024.



Fuente: Elaboración propia. 2025.

En el último cuadro podemos observar que el brote fue más significativo que en el primer período (2023 - 2024) si bien es el mes de marzo donde se presenta la máxima cantidad de casos tanto en el año 2023 como en el 2024, ya que es la temporada más alta de la proliferación del mosquito. Sin embargo cabe resaltar que en el 2025 la cantidad de casos totales fue mucho menor.

Conclusiones

Retomando la pregunta de investigación que orientó este trabajo **¿Cuáles fueron los efectos que tuvo la campaña de prevención, control y vigilancia de la transmisión de las enfermedades producidas por el mosquito *Aedes aegypti* en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Comuna 11, durante los períodos 2023-2024 y 2024-2025?**, los resultados permiten afirmar que los efectos de dicha campaña fueron positivos.

El análisis de los datos evidencia un incremento significativo de las acciones comunitarias y comunicacionales durante el período 2024-2025 en comparación con el ciclo anterior. Este aumento se tradujo en una mayor participación ciudadana, tanto en las actividades de difusión y talleres de prevención como en la utilización del canal de denuncias para el control de focos, lo que refleja una interiorización más profunda del mensaje preventivo por parte de la población. **De este modo, puede inferirse que la intensificación y sostenimiento de las acciones comunicacionales y territoriales favoreció una mayor concientización social, lo que derivó en una contención más efectiva de los brotes de dengue.** Este efecto se ve respaldado por los datos que muestran una disminución notable de los casos confirmados en el segundo período analizado, **así como una respuesta más organizada ante la aparición de focos.**

Del análisis comparativo de los planes de comunicación de la Campaña de Prevención, Control y Vigilancia del Dengue en la Comuna 11 durante los períodos octubre 2023 - mayo 2024 y octubre 2024 - mayo 2025, se observan tanto continuidades como transformaciones significativas en la estrategia comunicacional del Ministerio de Salud de la Ciudad.

En cuanto al **objetivo comunicacional**, ambos períodos comparten el propósito de generar conciencia y prevenir la proliferación del mosquito *Aedes aegypti*. No obstante, mientras que en 2023-2024 el eje estuvo puesto en instalar el tema dengue tras el aumento de casos y fomentar la prevención doméstica, en 2024-2025 el foco se orientó a mantener la alerta y

consolidar hábitos preventivos, evidenciando un pasaje de la sensibilización inicial hacia el sostenimiento de conductas adquiridas.

Respecto de los **ejes temáticos**, se mantuvieron las consignas centrales “Eliminá los criaderos”, “Usá repelente” y “Consultá ante síntomas”, aunque en el segundo período se incorporaron componentes vinculados con el seguimiento de focos y la denuncia vecinal, lo que refleja una ampliación hacia la participación ciudadana activa.

En relación con los **canales de comunicación**, ambos planes sostuvieron una estrategia multicanal, combinando redes sociales, folletería, afiches y medios barriales. Sin embargo, en el segundo período se destaca un refuerzo de la presencia digital mediante campañas segmentadas, videos breves y spots radiales, ampliando así la cobertura y la llegada a distintos públicos.

Finalmente, el impacto observado permite identificar mejoras en los resultados tanto comunicacionales como epidemiológicos. Mientras el primer período registró un incremento moderado de consultas y participación, el segundo mostró mayor uso de los canales de denuncia, descenso de casos confirmados y una cobertura territorial más amplia, evidenciando una mayor eficacia del plan comunicacional implementado.

En consecuencia, los hallazgos permiten confirmar la hipótesis planteada: una campaña más sostenida, visible y con presencia territorial se asocia a un aumento de la concientización y participación ciudadana y, en consecuencia, a una contención de los posibles brotes ocasionados por la enfermedad. En síntesis, ambos planes comparten la continuidad de los ejes preventivos pero el período 2024-2025 se distingue por una mayor madurez estratégica, con acciones más diversificadas, una comunidad más involucrada y resultados más favorables en la gestión del riesgo sanitario.

Acción	**Periodo octubre 2023 a mayo 2024**	**Periodo octubre 2024 a mayo 2025**	**Comentario**
Actividades (concientización, talleres y gestion	No hay registro	Se registran los 3 tipos de actividades.	Se incorporó la denuncia vecinal en el segundo

denuncias)			período.
Oviposturas positivas	Promedio 330	Promedio 19	Se observa baja de oviposturas positivas
Estudios de focos	Sólo en presencia de clusters y con seguimiento telefónico	Seguimiento presencial de la persona confirmada de dengue y del perímetro del domicilio	Se suman operativos puerta a puerta.
Plan de comunicación	Redes sociales institucionales (Instagram, Facebook, Twitter), folletería, afiches, medios barriales.	Redes sociales reforzadas, incorporación de campañas digitales segmentadas, videos breves y spots radiales.	Se mantiene la multicanalidad, pero aumenta la presencia digital y territorial.
Casos confirmados de dengue	Promedio 185	Promedio 52	Se observa baja de casos confirmados

Propuestas a futuro

Para la mejora de futuras campañas creemos que es importante no solo sostener estrategias comunicacionales integrales, segmentadas y territorializadas sino también acompañarlas con sistemas de monitoreo que permitan evaluar su impacto de manera continua. A partir de la experiencia analizada, sostenemos que la prevención del dengue debe pensarse como una política pública dinámica, que articule comunicación, territorio y vigilancia epidemiológica de forma sostenida en el tiempo.

Es por eso que con el objetivo de profundizar y dar continuidad al análisis realizado, se propone implementar cuestionarios de evaluación interna como lo que se elaboraron a modo de prueba en este trabajo y que están dirigidos a distintos actores clave involucrados en la implementación de la campaña (nivel central, comunicación y epidemiología)[10]. Estos instrumentos permiten relevar las percepciones cualitativas sobre la planificación de los operativos, la suficiencia de los recursos humanos, el funcionamiento de los sistemas de denuncia, el rol de la comunicación institucional y el impacto general de las acciones implementadas en ambos períodos analizados. Se considera pertinente proponer la implementación periódica de encuestas similares como herramienta de evaluación continua de la política pública, tanto para medir resultados como para identificar oportunidades de mejora en tiempo real. La sistematización regular de este tipo de relevamientos permitiría fortalecer los procesos de toma de decisiones, optimizar las estrategias comunicacionales y consolidar un enfoque preventivo más eficiente y participativo.

De este modo, el anexo no solo complementa la investigación desarrollada, sino que también plantea una línea de trabajo futura orientada a la mejora continua de las campañas de prevención, control y vigilancia del dengue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[10] Ver Anexo.

Bibliografía

Argentina. (2009). *Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud*.

Coordinación ETM. (2025). *Acciones de territorio (Respuestas).xlsx 2024-2025*. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gqah82JdPzkHf5cabGTeRqhLPysX7Evi/edit?gid=1209315339#gid=1209315339

Coordinación ETM. (2025). *Campaña comunicacional ETM*. https://docs.google.com/presentation/d/10NsfJNGrjoDPf94-XxrOVgeSGVJAB0Pk/edit?slide=id.p1#slide=id.p1

Coordinación ETM. (2025). *Plan ETM 24-25*. https://docs.google.com/presentation/d/1CKE2uI62RDR_PF4YGF-AMDvRtf4vrI1o/edit?slide=id.p1#slide=id.p1

Coordinación ETM. (2024). *Seguimiento Operativo y Cronograma Dengue 2024*. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_FiVwOwR8GVfuRcXqWf5ET10r_FtQ4-G/edit?gid=495854683#gid=495854683

Béliveau, V., & Durán, C. (2017). Salud pública basada en evidencias en América Latina. *Revista de Salud Pública*, 19(3), 215-223.

Buss, P. M., & Pacheco, S. (2015). Determinantes sociales y ecosistémicos de la salud en América Latina. *Cadernos de Saúde Pública*, 31(3), 471-480.

Carrillo, R. (2018). *Política sanitaria argentina*. Universidad Nacional de Lanús. https://isco.unla.edu.ar/edunla/cuadernos/catalog/book/2

Frenk, J. (2010). La reforma del sistema de salud en México: Experiencia y perspectivas. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 27(1), 87-94.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2023). *Campaña contra el dengue*. Ministerio de Salud de CABA. https://www.buenosaires.gob.ar/salud/campañas/dengue

Organización Mundial de la Salud (WHO). (2013). *Health in all policies: Framework for country action*. https://www.who.int/publications/i/item/9789241506908

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2007). *La atención primaria de salud: Una estrategia para alcanzar la cobertura universal*. OPS.

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2016). *Salud en todas las políticas: Un enfoque multisectorial para mejorar la salud y la equidad*. OPS.

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2020). *Gestión integrada para la prevención y el control del dengue en las Américas*. https://www.paho.org/es/documentos/gestion-integrada-prevencion-control-del-dengue

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2022). *Guía para el control vectorial del Aedes aegypti*. https://www.paho.org/es/temas/dengue

Vargas, L., & Pérez, R. (2013). Gobernanza en salud: Desafíos para América Latina. *Revista Latinoamericana de Salud Pública*, 22(2), 104-112.

Vilas, C. M. (1994). *Estado y políticas sociales en América Latina: Hacia una estrategia de desarrollo con equidad*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Anexo

Cuestionario modelo para Coordinación ETM

I. Preguntas abiertas:

¿Qué diferencias se registran en la cantidad y calidad de las acciones comunicacionales en la Comuna 11 entre los períodos 2023–2024 y 2024–2025?

II. Preguntas de opciones:

Operativos territoriales

¿Hubo previsibilidad en la planificación de los operativos?
☐ Sí ☐ No ☐ Parcialmente

¿Qué dificultades se presentaron con mayor frecuencia?
☐ Falta de personal
☐ Falta de insumos
☐ Problemas de coordinación
☐ Resistencia vecinal
☐ Otras: .....

Recursos Humanos (RRHH)

¿Considera que los recursos humanos fueron suficientes para sostener los operativos?
☐ Sí ☐ No ☐ Parcialmente

En caso negativo, ¿en qué áreas se evidenció mayor faltante de personal?
☐ Territorio ☐ Comunicación ☐ Atención sanitaria ☐ Todas

Denuncias y tecnología

¿El sistema de denuncias fue una herramienta útil para el control del mosquito?
☐ Muy útil ☐ Útil ☐ Poco útil ☐ Nada útil

¿Considera que la opción de denuncia mediante Boti debería reforzarse en futuras campañas?
☐ Sí ☐ No ☐ No sabe

Evaluación general

¿Cree que la campaña 2024–2025 fue más efectiva que la 2023–2024?
☐ Sí ☐ No ☐ Parcialmente

Desde su experiencia, ¿qué mejoras propondría para futuras campañas?

Cuestionario modelo para área de Comunicación

I. Preguntas abiertas:

¿Considera que la falta de datos de impacto en redes limita la planificación de las campañas de comunicación?

¿Cómo podría optimizarse la segmentación de los mensajes para distintos públicos?

II. Preguntas de opciones:

¿Considera que la comunicación de la campaña fue suficiente para llegar a la población?
☐ Muy suficiente ☐ Suficiente ☐ Poco suficiente ☐ Insuficiente

La falta de datos de alcance e interacción en redes sociales:
☐ Dificultó la planificación
☐ No generó impacto significativo
☐ No fue tenida en cuenta
☐ No sabe / No responde

¿Cree que los mensajes estuvieron correctamente segmentados según el público destinatario?
☐ Sí ☐ Parcialmente ☐ No

Explique:

.....

Evaluación general

¿Cree que la campaña 2024–2025 fue más efectiva que la 2023–2024?
☐ Sí ☐ No ☐ Parcialmente

Desde su experiencia en el sector de Comunicación, ¿qué mejoras propondría para futuras campañas?

.....

Epidemiología

¿Qué efectos tuvo el incremento de acciones comunicacionales y territoriales de la campaña en los indicadores epidemiológicos de la Comuna 11?

¿Qué aspectos del plan resultaron más difíciles de medir por falta de datos?

Evaluación general

¿Cree que la campaña 2024–2025 fue más efectiva que la 2023–2024?
☐ Sí ☐ No ☐ Parcialmente

Desde su experiencia, ¿qué mejoras propondría para futuras campañas?

.....